*Fabio Folgheraiter*
*(a cura di)*

# Il servizio sociale postmoderno

## *Modelli emergenti*



Erickson

Il servizio sociale postmoderno
F. Folgheraiter (a cura di)
Erickson

*Editing*
Annalisa Pasini

*Fotocomposizione*
Mirko Pau

*Copertina*
Giordano Pacenza

---

© 2004 Edizioni Erickson
Loc. Spini, 154
38014 Gardolo – Trento
Tel. 0461 950690
Fax 0461 950698
www.erickson.it
info@erickson.it

*Stampa*
La Grafica – Mori (TN)

*ISBN:* 88-7946-670-4

*Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo effettuata, se non previa autorizzazione dell'Editore.*

*Fabio Folgheraiter (a cura di)*

# Il servizio sociale postmoderno

## *Modelli emergenti*

Erickson

asilari «totali», persone che, ritrovandosi ancora abbastanza «integre», hanno beneficiato di programmi di deistituzionalizzazione e di reinserimento comunitario. Essi si definiscono «sopravvissuti» *(survivors)* rispetto all'azione di quelle strutture che, per perseguire l'obiettivo di prendersi cura di loro o finanche di guarirli, li hanno per così dire confiscati, esercitando un controllo totale su ogni aspetto della loro esistenza. Il rischio, di cui si è via via estesa la consapevolezza, era quello che l'internamento producesse destrutturazioni e danni permanenti nella personalità e nella capacità di azione dei sottoposti a una tale misura. Nonostante ciò, molti sopravvissuti e fuoriusciti da tali rischiose istituzioni si sentono in grado di (sentono di «avere il potere di») agire in forma collettiva, per riequilibrare le posizioni di potere rispetto a chi è ufficialmente abilitato a effettuare diagnosi su di loro e per affermare il diritto a decidere delle loro vite nonostante gli handicap o le malattie che oggettivamente li riguardano. Questi ex pazienti concepiscono l'empowerment come un loro diritto di azione diretta. Essi non respingono solo l'idea che i professionisti della psichiatria classica possano continuare a occuparsi di loro. Più in generale, essi negano con forza che il loro «potenziamento» possa essere la conseguenza intenzionale di una nuova sofisticata tecnica professionale detta appunto empowerment, esercitata «su di loro» ancora una volta come uno strumento di potere a favore di chi lo utilizza.

### *L'empowerment relazionale: il lavoro sociale di rete*

Esiste una concezione intermedia tra l'idea che l'empowerment sia un avanzato e illuminato procedimento tecnologico che, in ultimo, serve a far aumentare l'efficienza e il potere dei professionisti, e l'idea che esso sia un'esclusiva rivendicazione di autonomia e di potere di una parte soltanto, quella che si reputa svantaggiata. È quanto emerge seguendo il filone di pensiero che origina dalla fenomenologia e dalle istanze postmoderne, una prospettiva che vede il processo di aiuto professionale non come l'esatta applicazione di una competenza tecnica esclusiva, bensì come un incerto ma fiducioso iter di «ricerca», condivisa tra tutti i potenziali interessati alla soluzione di un problema. In questa ottica gli utenti, i carer, gli specialisti e tutti i cittadini interessati, per quanto portatori di interessi differenti, sono incoraggiati a uscire in parte dalla rigida polarizzazione dei loro ruoli per



divenire agenti tendenzialmente «alla pari», nella ricerca del benessere cui sono cointeressati (Folgheraiter, 1998; 2000).

Secondo questo modo di interpretare il lavoro sociale, gli utenti divengono di fatto «operatori», cioè vedono aperta davanti a sé la strada per agire nello stesso modo in cui agisce un operatore professionista: sentendosi in grado e «autorizzati» a esprimere creatività e responsabilità per la ricerca di soluzioni. La metodologia di rete prevede, quanto all'empowerment, che i detentori ufficiali del potere terapeutico cedano parte di questo potere alle persone che tradizionalmente stavano ad attendere passive le soluzioni «certe» da loro pensate. In questo senso si può dire che «l'utente non c'è» (Folgheraiter, 2000) essendo egli concepito come un «agente» capace (e comunque non impedito dall'esercizio altrui) di intraprendere quel tipico genere di azioni (esprimere i propri punti di vista, ponderare le cose, prendere decisioni, valutare l'efficacia delle azioni intraprese, ecc.) che sono da sempre considerate appannaggio di chi è abile a risolvere i problemi.

L'esperto cede potere, cioè lascia fare agli interessati quanto è in loro potere fare, anzi incentiva il loro fare e il loro decidere predisponendo condizioni favorenti e assicurando l'opportuna supervisione, permettendo così agli interessati di concorrere alla pianificazione profonda del loro aiuto o della rivendicazione dei loro diritti. Gli specialisti a loro volta traggono da questa aumentata «produttività sociale» rinnovato potere e impensate opportunità di apprendimento. L'idea è che l'operatore non abbia il mandato di potenziare le persone, ma che le persone siano agenti sensati, per quanto deboli e svantaggiate appaiano agli occhi di chi si trova in posizioni «superiori». Da parte dei professionisti, va soprattutto evitato il rischio di smantellare involontariamente questo intrinseco potere d'azione attraverso concezioni paternalistiche e assistenzialistiche, sulla base della subdola idea che i problemi sociali abbiano soluzioni oggettive e «migliori» e che queste vadano comunque imposte, in omaggio a un presunto dovere di impiantare nel mondo la «felice perfezione» della razionalità oggettiva.

L'empowerment inteso come «trasferimento di potere» da ruoli istituzionali e professionali al mondo della vita non è, in questa prospettiva, un gioco a somma zero (Barnes e Bowl, 2003). L'ottica relazionale invita a riflettere sul fatto che se il professionista cede potere ai suoi interlocutori ne riceve in cambio di nuovo, in quantità e qualità non esistente prima dell'interazione. Quando il potere è scambiato e intrecciato, piuttosto che semplicemente «ceduto», esso si ri-genera e si moltiplica.

*Cedere potere è un cedimento di professionalità, o piuttosto viceversa?*

Le argomentazioni sviluppate sin qui possono essere approfondite alla luce della teoria sociologica della professionalizzazione. Guardando bene tra le righe di quanto detto, al professionista esperto potrebbe apparire chiara la possibilità di elevare il livello della propria professionalità. Nella cornice dell'approccio relazionale postmoderno, egli andrebbe a differenziare le proprie funzioni e, accanto al suo tradizionale ruolo terapeutico se lo vuole mantenere, entro i limiti sopraddetti, potrebbe assumere un ruolo strategico di più elevato tenore. Egli diventa *guida professionale delle iniziative terapeutiche altrui*. Lungi quindi dal sentirsi sminuito nel suo potere tecnico dal protagonismo (potere) di altri, anche non professionisti, nel suo stesso campo di intervento, l'operatore specialista dovrebbe essere stimolatore/supervisore di questi poteri «esterni» affinché il tutto si traduca in un maggiore potere comune (comunitario) e anche senz'altro in una maggiore efficacia dell'istituzione per cui lavora (che a sua volta, essendo istituzione di welfare, si traduce in benessere generale della società). L'attività di supervisione intenzionale dell'*agency* societaria finalizzata al welfare è una competenza o meglio una capacità esclusiva, tipicamente professionale, in quanto solo un professionista sofisticato riesce a sostenerla con piena intenzionalità.

Si potrebbe qualificare come «super-professionista» quell'operatore che è appunto così avanzato da riuscire a ritagliarsi un ruolo di ordinatore e osservatore di molteplici iniziative, sia di carattere esperto che esperienziale, che si sviluppano entro il suo raggio d'azione, iniziative che non hanno bisogno di lui materialmente per realizzarsi ma che forse senza la sua stimolazione non si sarebbero messe in moto e senza la sua continua osservazione a supporto non saprebbero mantenersi nel tempo riproducendosi, o non riuscirebbero ad assicurare una qualità accettabile. È risaputo che le energie comunitarie di carattere informale possono prendere «coraggio» e sentirsi tonificate dalla presenza, dietro le loro spalle, di una risorsa professionale di questo livello, cognitivamente orientata all'empowerment. Come detto, tale risorsa deve stare in equilibrio su un filo sottile. Deve essere attenta a non soffocare le possibili azioni consorelle agendo *al posto loro*, con il pretesto di far meglio, oppure semplicemente perché non si rende neppure conto che tali risorse «altre» esistono, o potrebbero esistere. Al contrario, neppure deve lasciarle in balia di carichi pesanti e ingestibili, senza un'adeguata



riflessione di fronteggiamento. Il «super professionista» postmoderno deve fare lasciando fare, o lasciar fare facendo, il che è obiettivamente complicato, ma forse meno di quanto sembri. In ogni caso questo suo posizionamento intelligente — un passo indietro per stimolarne molti più di quanti potrebbe farne lui direttamente — solo con una valutazione superficiale può essere scambiato per una perdita di potere e di prestigio professionale: in realtà l'operatore guadagna in autorevolezza ed efficacia, più di quanto è possibile immaginare in astratto, finché non si prova davvero a cimentarsi.

Per poter svolgere il ruolo di guida di relazioni autonome che concorrono al suo stesso obiettivo, l'operatore deve disporsi con un animo aperto e sereno, deve essere consapevole della sua forza e della forza (differente dalla sua, ma anch'essa importante) delle altre persone che incontra nel lavoro. Dovrebbe assumere nel relazionarsi un atteggiamento di «potenziamento dell'altro», identificato come importante dagli utenti recuperati che guardano indietro e vedono le competenze professionali che più li hanno aiutati nel loro recupero, o che più avrebbero desiderato incontrare (Ribner e Knei-Paz, 2002).

*In sintesi*

Questi sono i principi a cui devono riferirsi gli operatori sociali professionali che vogliono adottare l'orientamento dell'empowerment in una concezione che non sia né paternalistica né delegante, ma pienamente relazionale:

1. L'empowerment è un processo collaborativo nel quale utenti, carer e cittadini da un lato e operatori dall'altro trovano facilitazioni nel lavorare assieme come partner.
2. Il processo di empowerment vede gli utenti come soggetti potenzialmente competenti e capaci di decidere che cosa è bene per la loro vita.
3. Gli utenti sono considerati in grado di autopercepirsi come agenti di cambiamenti significativi nella loro vita, così come anche nelle interazioni «tecniche» con gli operatori professionali, là dove si costruiscono le «terapie».
4. La competenza viene acquisita o affinata attraverso un'azione corroborata dalle esperienze di vita. Gli operatori d'empowerment quindi non sostituiscono l'azione degli interessati per sfiducia preconcetta, ma la «aspettano», la sostengono, eventualmente dando feedback per orientarla.

5. Dall'empowerment dei propri interlocutori (cioè dal rafforzamento del loro senso di avere potere) gli operatori traggono opportunità di apprendimento e aiuti per l'esercizio delle competenze «esperte», e così di seguito circolarmente.
6. L'azione degli interessati alla soluzione dei problemi che li riguardano può estendersi oltre la sfera delle loro circostanze «private» e dipanarsi collettivamente per modificare il sistema politico o socioculturale dominante. Anche in questi casi, gli operatori professionisti possono assecondare i processi in atto, fin dove il loro ruolo istituzionale e le loro convinzioni di cittadini lo consentono.

## Bibliografia


Alinsky S. (1971), *Rules for radicals*, New York, Vintage Books.

Bailey R. e Brake M. (a cura di) (1975), *Radical social work*, London, Edward Arnold.

Bandura A. (2000), *Autoefficacia. Teoria e applicazioni,* Trento, Erickson.

Barnes M. (1999), *Utenti, carer e cittadinanza attiva. Politiche sociali oltre il welfare state,* Trento, Erickson.

Barnes M. (2001), *Utenti come cittadini: nuovo forme di governance del welfare locale,* «Lavoro Sociale», vol. 1, n. 3, pp. 365-382.

Barnes M. e Bowl R. (2003), *Empowerment e salute mentale,* Trento, Erickson.

Bartlett H. (1971), *The common base of social work practice,* New York, NASW.

Bell M. (2001), *Il coinvolgimento della famiglia negli interventi per minori a rischio,* «Lavoro Sociale», vol. 1, n. 2, pp. 167-187.

Blakemore K. (1998), *Social policy: An introduction*, Buckingham, Open University Press.

Bauman Z. (1996), *Le sfide dell'etica,* Milano, Feltrinelli.

Beck U. (2000), *La società del rischio: verso una seconda modernità,* Roma, Carocci.

Bortoli B. (1997), *Teoria e storia del servizio sociale,* Roma, Carocci.

Bortoli B. (2003), *Che cos'è il case management?,* in F. Folgheraiter (a cura di), *La liberalizzazione dei servizi sociali,* Trento, Erickson.

Bortoli B. (2004), *Biografie. Mary Richmond: la fondatrice del servizio sociale professionale,* «Lavoro Sociale», vol. 4, n. 2, pp. 265-278.

Bortoli B. (2004a), *Biografie. Jane Addams: tra impegno sociale e impegno politico fino al Nobel per la pace,* «Lavoro Sociale», vol. 4, n. 1, pp. 123-132.





Bury, M. (1998), *Postmodernity and health*, in Srambler, G. and Higgs, P., *Modernity, medicine and health*, London, Routledge.

Colaianni L. (2004), *La competenza ad agire: agency, capabilities e servizio sociale,* Milano, Angeli.

Davies R.(a cura di) (1998), *Stress in social work,* London, Jessica Kinsley.

Donati P. (1991), *Teoria relazionale della società,* Milano, Angeli.

Donati P. (1996), *Sociologia del Terzo settore,* Roma, NIS.

Donati P. (1998), *Lezioni di sociologia*, Padova, Cedam.

Donati P. e Folgheraiter F (a cura di) (1999), *Gli operatori sociali nel welfare mix: Privatizzazione, pluralizzazione dei soggetti erogatori, managerialismo,* Trento, Erickson.

Ferguson H. (2002), *Lavoro sociale e politiche della vita,* «Lavoro sociale», vol. 2, n. 3, pp. 303-321 (in questo volume).

Ferrari E. (a cura di) (2000), *I servizi a rete in Europa. Concorrenza tra gli erogatori e garanzia dei cittadini,* Milano, Cortina.

Fletcher K. (2000), *La negoziazione nei servizi sociali e sanitari,* Trento, Erickson.

Folgheraiter F. (1994), *Interventi direte e comunità locali,* Trento, Erickson.

Folgheraiter F. (1998), *Teoria e metodologia del servizio sociale. La prospettiva direte,* Milano, Angeli.

Folgheraiter F. (1998b), *L'approccio relazionale in educazione e terapia: tre studi di caso*, «Difficoltà di apprendimento», vol. 4, n. 1, pp. 95-113.

Folgheraiter F. (2000), *L'utente che non c'è. Lavoro direte ed empowerment nei servizi alla persona,* Trento, Erickson.

Folgheraiter F. (a cura di) (2003), *La liberalizzazione dei servizi sociali,* Trento, Erickson.

Gallino L. (1993), *Dizionario di sociologia*, Torino, Utet.

Giddens A. (1991), *Modernity and self-identity*, Cambridge, Polity.

Giddens A. (1994), *Le conseguenze della modernità: fiducia e rischio, sicurezza e pericolo,* Bologna, Il Mulino.

Gutierrez L.M. (1994), *Beyond coping: An empowerment perspective on stressful life events*, «Journal of Sociology and Social Welfare», n. 21, pp. 201-219.

Haley J. (1977), *Le strategie della psicoterapia,* Sansoni, Firenze.

Heron (2002), *Aiutare i carer*, Trento, Erickson.

Johnson L.C. e Yanca S.J. (2001), *Social work practice: A generalist approach,* Boston, Allyn and Bacon.

Kelly H.H. (1979), *Personal relationship: Their structure and process,* Hillsdale, LEA Publ.

Kropotkin P. (1914), *Mutual aid,* Boston, Extending Horizon Books.

Langan M. (1998), *Radical social work.* In R. Adams, L. Dominelli e M. Payne (a cura di), *Social work. Themes, issues and critical debates*, London, Macmillan.